

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

PHTLS

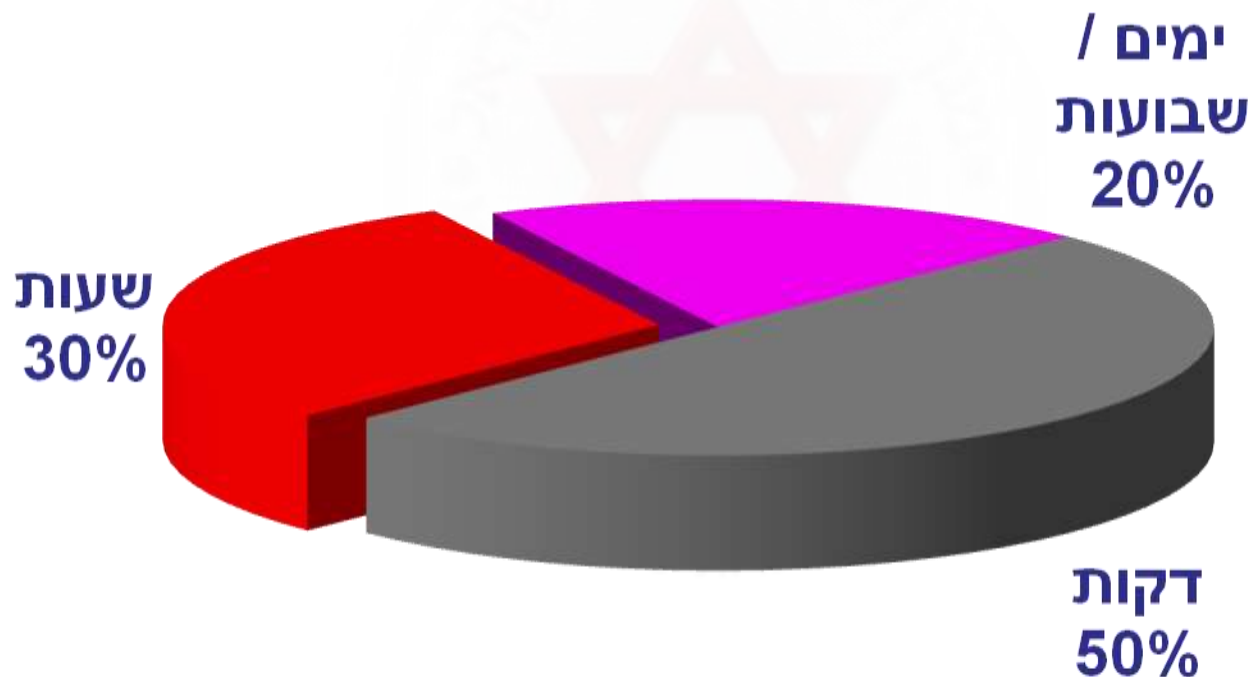
**Pre Hospital Trauma Life
Support**

סכמה טיפול בפצוע בודד



- PHTLS הינה סכמה לטיפול בפצוע אחד ע"י שני מטפלים ומעלה

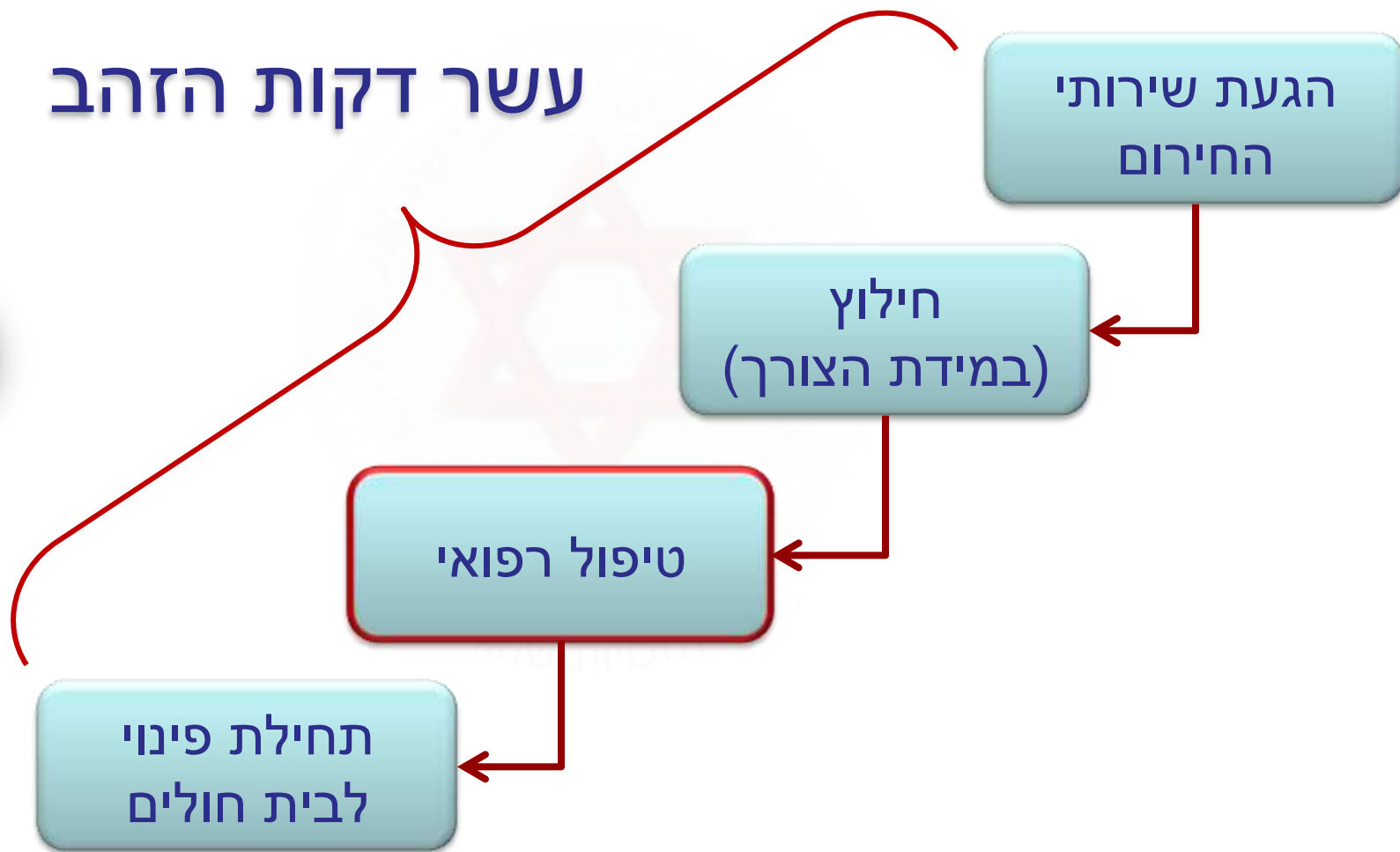
- אחוזי תמותה:





מבוא – הטיפול בנפגע

עשר דקות הזהב





Safety – בטיחות

• Safety + Survey

- בטיחות (של הצוות, של הפצוע, של עוברי אורח).
- הערכת רמת ההכרה
- הזמנת כוחות נוספים (משטרה, כיבוי, אמבולנסים)
- דיווח ראשוני למוקד
- סקירת זירת הארוע (מנגנון הפגיעה, כמות הפצועים בשטח, עוצמת הפגיעה), ניטרול סכנות.
- מהות האירוע (ירי, תאונת דרכים, דקירה וכו'....).
- במידת הצורך הזעק גורמי עזרה נוספים
- התרשמות מקינמטיקה
- עצירת שטפי דם פעילים בלבד

זכור- איש צוות פצוע לא יכול לטפל

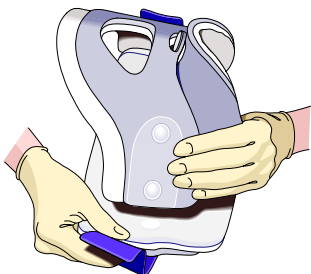
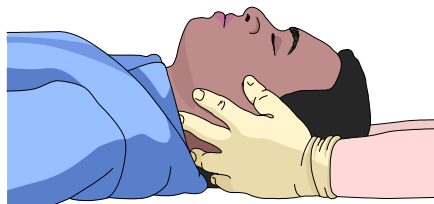


סבב ראשוני

- הערכה ראשונית של הנפגע ואופי הפציעה



טיפול ראשוני במצבים מסכני חיים



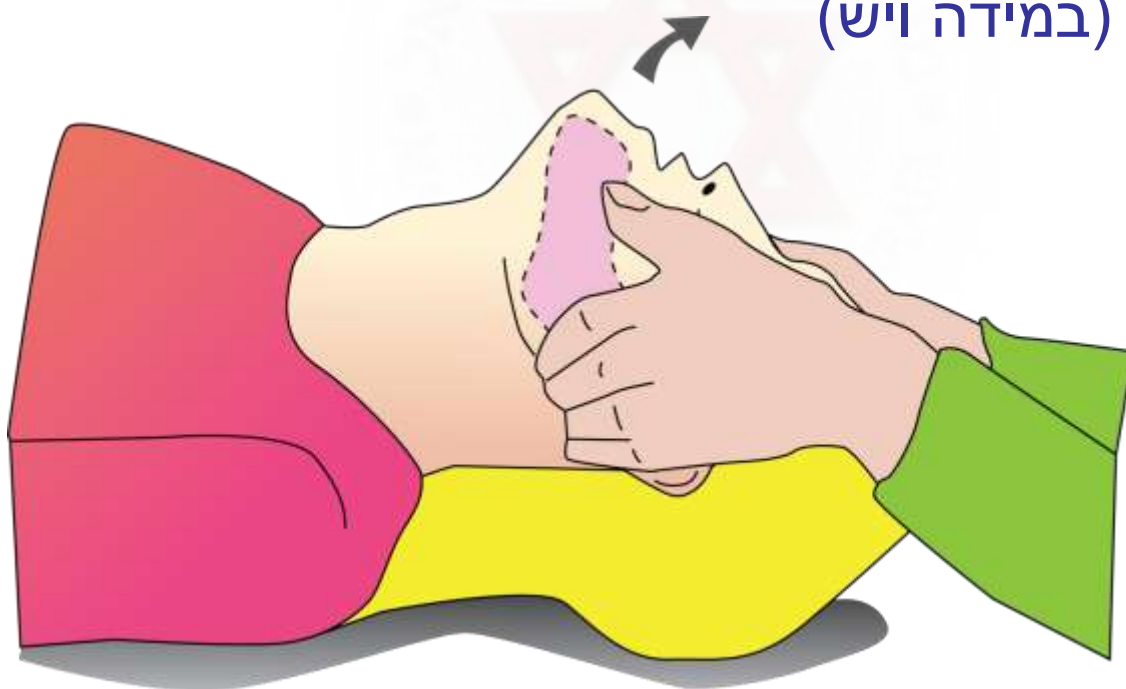
- Airway + עמש"צ
- Breathing
- Circulation
- Disability
- Exposure
- T&T

כל הזכויות שמורות



Airway – נתיב אויר ועמש"צ

- קיבוע ידני ראש וצוואר לאורך הטיפול כולו
- סילוק הפרשות
- פתיחת נתיב אויר בשיטת דחיקת לסת/הרמת סנטר
- צווארון פילדלפיה יותקן בהקדם
- הסרת קסדה (במידה ויש)





Breathing – אבטחת נשימה

- ודא קיום נשימה ספונטנית – הנשם נפגע אינו נושם
- הערך יעילות נשימה (קצב, עומק סימטריות, הקשב לדיבור הנפגע).
- אם קיימת מצוקה נשימתית תן חמצן
- בצע סיוע נשימתי מעל 30 נשימות בדקה או מתחת ל-10 נשימות בדקה
- בדוק חזה הפצוע, במידת הצורך הפשט פלג גוף עליון וטפל





– Circulation

אבטחת זרימת דם



• עצירת שט"דים

• דופק רדיאלי-עוצמה (60,70,80)

• מילוי קפילרי- מעל 2 שניות- ירידה בפרפוזיה- הלב

• עור-צבע, טמפרטורה, זיעה





-Disability בדיקה נוירולוגית

- בדוק רמת הכרה

1. Alert – הכרה מלאה

2. Verbal – תגובה לקול

3. Painful – תגובה לכאב

4. Unresponsive – חסר תגובה

- בדיקה השוואתית של אישונים

- הערכה תנועתית ותחושות גפיים





Exposure – הפשטה

- הקפד לחשוף את פלג הגוף העליון והגפיים על מנת למצוא שטפי דם נסתרים
- הפשטת הנפגע תתבצע במידת האפשר באמבולנס
- הקפד לכיסוי מתאים לאחר ההפשטה



זכור! שמור על צנעת הפרט והימנעות מהיפוטרימיה



- האם קיים איום על A? דימום מסיבי מהפה, בצקות באיזור, גופים זרים וכו'

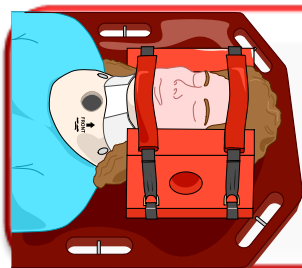
- האם קיים איום על B? פגיעות חזה, נשימות לא יעילות, מצוקה נשימתית וכו'

- האם קיים איום על C? שטפי דם שלא נעצרו, אי יכולת למצוא דופק רדיאלי וכו'

- האם יש פגיעת ראש?

- האם יש ירידה ברמת ההכרה?

- קינמטיקה קשה (נפל מגובה פי 3, נפגעים מתים באירוע וכו')



הוחלט לפנות?

קבע ללוח גב

הסבב השניוני יבוצע במהלך הפינוי



• הערכה חוזרת של הפצוע.

– **Airway** – בדוק ראש וצוואר, הרכב צווארון אם עוד
לא הורכב

– **Breathing** – בדוק חזה בצורה יסודית, עקוב אחר מצב
הנשימה

– **Circulation** – לחץ דם, בדיקת פגיעות בטן,
החדרת עירוי (במידת הצורך)

– **Dressing** – חבישות, קיבועים וקיבוע ללוח גב (במידה
ואנחנו מטפלים בשטח)

– **Evacuation** – הכנה לפינוי, פינוי





טיפול בפצוע/חולה – הבדלים

• שלב ה-A

- שמירה על עמוד שדרה צווארי
- פתיחת נתיב אוויר ע"י Jaw Thrust, ללא הטיית ראש לאחור (במידת האפשר)



• שלב ה-B

- חשיפת וחיפוש אחר חבלות בבית חזה
- הנחת אשרמן
- הנשמה באמבו ע"י שני אנשי צוות



© כל הזכויות שמורות



- סכמת הטיפול בפצוע משמשת אותנו בכל מקרי הטראומה

- הסכמה היא חלק קטן מתוך 10 דקות הזהב

- יש לעשות עיסויים בטראומה!

- מה שיהרוג קודם יטופל קודם

- ברמת השטח "האויב הגדול" הינו הזמן!

- חשוב לזכור! שריטה בבוהן אפשר לחבוש בבית החולים, אך
טחול מדמם אי אפשר לרפא בשטח!



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

שאלות



© כל הזכויות שמורות